

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°143 /MVE-BDBV/04/10/2026

Date du rapport : 04 octobre 2026

Date de publication : 05 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au décours des dernières 24 h, 59 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 23 décès communautaires ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces du Nord-Kivu (33 cas), de l'Ituri (23 cas) du Haut-Uélé (2 cas) et de la Tshopo (1 cas). De plus, 11 décès ont été enregistrés dans les CTE

- Un total de 331 nouveaux échantillons a été analysé ; 59 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 17,8% de positivité.

CUMUL DES
CAS
8 603

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
4 148

LETALITE
48,2 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
896

CUMUL DES
GUÉRIS
2 235

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
79,7 %



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



64 Zones de santé
touchées sur 167
(38,3%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au terme de la journée du 04 octobre 2026, 59 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont 23 décès communautaires ont été notifiés dans 4 provinces : le Nord-Kivu (33 cas), l'Ituri (23 cas), le Haut-Uélé (2 cas) et la Tshopo (1 cas).

De plus, 11 décès ont été enregistrés dans les CTE (4 en Ituri, 3 au Nord-Kivu 3 au Haut-Uélé) et à la Tshopo (1), ce qui porte à 34 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Néanmoins, 5 patients (4 en Ituri et 1 au Haut-Uélé) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs au test de control à la MVE.

En date du 04 octobre 2026, la RDC cumule 8 603 cas confirmés et 4 148 décès (létalité : 48,2 %). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec 75,0 % des cas confirmés cumulés rapportés et 39,0 % des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit 58,1%.

64 zones de santé sur 167 (38,3 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 04 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	23	6450	2 968	46,0%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	33	1729	1 005	58,1%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	2	359	152	42,3%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	1	50	17	34,0%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	59	8 603	4 148	48,2%	64/167 (38,3 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 04 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6450	2968	46,0%	23	12	4	16
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	208	46	22,1%	4	0	0	0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1779	584	32,8%	10	6	1	7
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	83	31	37,3%				0
Gethy	9	5	55,6%	2	2	0	2
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	175	107	61,1%				0
Lita	294	147	50,0%	3	1	0	1
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	34	9	26,5%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	37	16	43,2%	1	1	0	1
Mandima	176	84	47,7%				0
Mangala	365	157	43,0%	0	0	1	1
Mongbwalu	707	335	47,4%			1	1
Nia-Nia	311	175	56,3%	1	1	0	1

Nizi	786	282	35,9%				0
Nyankunde	130	37	28,5%				0
Rimba	13	5	38,5%				0
Rwampara	1114	380	34,1%	2	1	1	2
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1729	1005	58,1%	33	10	3	13
Beni	393	260	66,2%	8	3	1	4
Biena	20	7	35,0%				0
Butembo	280	180	64,3%	5	2	2	4
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	60	21	35,0%				0
Katwa	600	370	61,7%	6	3		3
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	36	20	55,6%				0
Lubero	22	11	50,0%				0
Mabalako	46	18	39,1%	1	1		1
Alimbongo	4	2	50,0%				0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	32	11	34,4%	1			0
Musienene	138	69	50,0%	10	1		1
Mutwanga	16	3	18,8%				0
Oicha	31	16	51,6%				0
Vuhovi	34	10	29,4%	2			0
Haut-Uélé	359	152	42,3%	2	1	3	4
Boma Mangbetu	43	18	41,9%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	90	43	47,8%	0	0	3	3
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	116	43	37,1%	2	1	0	1
Tshopo	50	17	34,0%	1	0	1	1
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	27	11	40,7%			1	1
Mangobo	8	3	37,5%	1	0	0	0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0

Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8603	4148	48,2%	59	23	11	34

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.
NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 04 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	16	3	19	16	1	2	0	17	13
Bas Uélé	91	2	93	5	2	86	0	7	0
Ituri	1 038	69	1107	67	69	971	0	136	55
Nord-Kivu	657	30	687	61	30	596	0	91	44
Sud Ubangi	36	0	36	0	0	36	0	0	
Tshopo	49	0	49	5	0	44	0	5	0
Total Général	1 887	104	1 991	154	102	1 735	0	256	112

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

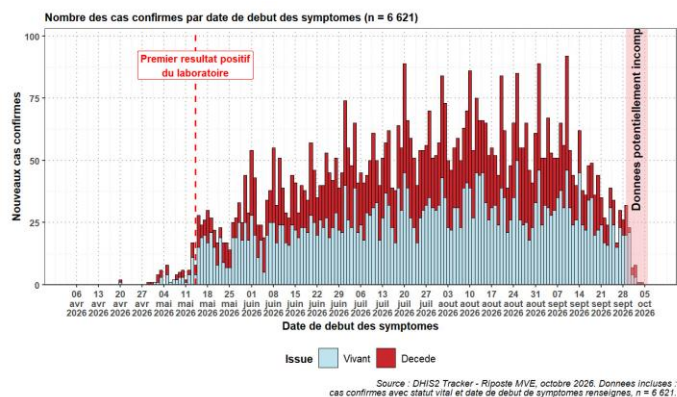
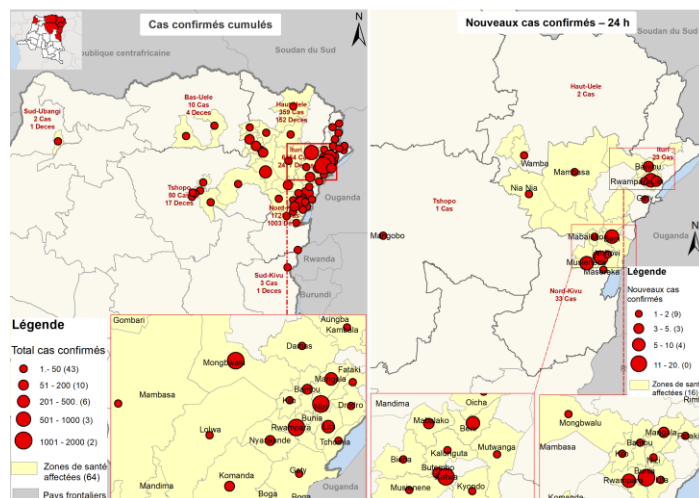


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme du 04 octobre, **1991** alertes (100 %) ont été vérifiées, dont **256** (12,9 %) validées comme cas suspects. Parmi ceux-ci, **256** (100%) ont été investigués. Ainsi, 112 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi **30 973 contacts en cours de suivi**, **24 673 ont été vus au cours des dernières 24 heures**, soit une proportion de suivi de **79,7 %**, en hausse par rapport à la veille (**73,8 %**), mais toujours inférieure au seuil requis de **95,0 %**. Cette proportion était de **97,7 % (43/44) au Sud-Ubangi**, **84,5 % (120/142) au Bas-Uélé**, **83,4 % (1 584/1 900) au Haut-Uélé**, **83,3 % (665/798) à la Tshopo**, **81,8 % (11 701/14 299) en Ituri** et **76,8 % (10 560/13 790) au Nord-Kivu**

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Trois (3) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée du 04 octobre, toutes en Ituri, dont une (1) validée comme cas suspect. Les deux alertes du PoC DGRPI Nizi (ZS de Nizi) ont été isolées puis invalidées après le dépistage secondaire, tandis que la suspecte validée au PoC Mabakese (ZS de Mambasa) a été investiguée et transférée au CT/CTE (taux d'investigation et de transfert de 100,0 % ; 1/1).

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 04 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	93,3% (56/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	94,9% (94/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	132 791	84 226	17 840	234 857
% des voyageurs screenés	95,9%	97,6%	99,5%	96,8%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,2%	97,6%	97,8%	97,4%
% des voyageurs sensibilisés	99,1%	97,6%	100,0%	98,6%
Nombre d'alertes notifiées	3	0	0	3
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	0	0	1
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	100,0%	NA	NA	100,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.2.2. Défis

Au Nord-Kivu, le PoC de Butuhe ne fonctionne plus depuis l'incident sécuritaire du 26 septembre (complétude de 95,2 % ; 20/21), 2,4 % des voyageurs ont refusé le screening et les prestataires des PoC de l'axe Butembo restent exposés à une menace sécuritaire persistante ; les alertes remontées par les PoC ne sont pas prises en charge dans les délais par les cellules d'alerte. À la Tshopo, 0,5 % des voyageurs ont refusé le screening et 2,2 % le lavage des

2.3.Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 23 nouveaux résultats positifs** (11 vivants et 12 décès) sur 146 échantillons reçus et analysés (**positivité : 15,8 %**).
- **Nord-Kivu : 33 nouveaux résultats positifs** (23 vivants et 10 décès) sur 161 échantillons reçus et analysés (**positivité : 20,5%**).

- **Haut-Uélé : 2 nouveaux résultats positifs** (1 vivants et 1 décès) sur 15 échantillons reçus et analysés (**positivité : 13,3 %**).
- **Tshopo : 1 nouveau résultat positif reçu** (1 vivants) sur 4 échantillons reçus et analysés (positivité : 25,0 %).
- **Bas Uélé : 5 échantillons** (2 sangs et 3 décès) reçus et analysés au laboratoire de Buta, **tous sont revenus négatifs**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 20 rings ont été ouverts sur 32 (62,5 %), 88 ménages décontaminés sur 88 (100 %) et 10 FOSA décontaminées sur 10 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 94 alertes EDS (dont 10 reports), 83 EDS ont été réalisés (88,3 %) et 68 corps swabés .
- **Nord-Kivu** : 12 rings ont été ouverts sur 25 (48,0 %), 14 ménages décontaminés sur 40 (35,0 %) et 19 ESS décontaminées sur 25 (76,0 %) ; aucun des 14 ménages décontaminés n'a été doté en kit et 21 évaluations score card PCI ont donné un score moyen de 33 %. Sur 44 nouvelles alertes EDS et 44 reports, 45 EDS ont été réalisés et 44 corps swabés.
- **Tshopo** : 1 ring a été ouvert à Makiso-Kisangani, le centre de traitement PPE a été décontaminé après le passage d'un suspect ; 11 matelas de remplacement ont été remis autour des cas confirmés et 9 ESS sur 9 ont été suivies dans 4 ZS, avec 74 prestataires briefés (100 %). En cumul, 37 ESS sur 37 (100 %) et 29 ménages sur 33 (87,9 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures.
- **Bas-Uélé** : 10 ESS sur 10 (100 %) ont été suivies à Viadana (3), Ganga (5), Buta (1) et Monga (1), 25 prestataires sur 25 (100 %) et 16 hygiénistes ont été briefés et 4 triages sur 5 (80,0 %) sont fonctionnels, le CS Rubi Lisanga (ZS de Buta) restant non fonctionnel ; 8 DLM sur 10 sont fonctionnels à l'HGR de Buta et 5 sur 5 au PoC Aéroport Zega, une décontamination préventive de la salle d'isolement et de la salle de réunion de l'HGR de Buta a été réalisée et 6 lits et matelas ont été remis à la salle d'isolement de Limba (OMS).

2.4.2. Défis

Au Nord-Kivu, seuls 12 rings sur 25 (48,0 %) ont été ouverts, avec un gap important à Katwa, Beni et Mabalako, la décontamination des ménages reste faible (35,0 % ; 14/40) à Katwa, Beni et Kalunguta et le score PCI moyen des ESS évaluées plafonne à 33 %. **À la Tshopo**, 5 corps n'ont pas pu être swabés, les intrants PCI et les prestataires formés restent insuffisants et l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani est toujours en panne. **Au Bas-Uélé**, la remontée des alertes de décès communautaires reste faible et tardive et les ESS manquent de zones de gestion des déchets, de latrines hygiéniques, de poubelles et de dispositifs de lavage des mains.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 75 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 58 sorties, dont 4 guérisons. Au total, 372 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée. Le taux d'occupation des lits était de **36,7 %** ; 313 patients sur 353 (88,7 %) ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (11/11), à la crèche (5/5) et dans la communauté (41/41) ; 33 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 61 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 48 sorties (aucun guérie). Au total, 382 patients demeuraient hospitalisés dont 263 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **63,0%** ; 243 malades ont bénéficié de repas chauds et 15 malades étaient en état critique, tous au CTE de Beni.
- **À la Tshopo**, 6 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 3. 20 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de 64,5 %.
- **Au Bas-Uélé**, 6 nouvelles admissions ont été enregistrées et 52 en isolement à la fin de la journée

- **Au Haut-Uélé**, 14 nouvelles admissions ont été enregistrées. Au total, 70 patients sont en isolement dans les CTE ; contre 15 sorties, dont 1 guérison, soit un taux d'occupation de **50,7 %**.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, faible capacité d'accueil des CTE/CT de Mambasa, Kilo, Mangala, Mandima et Lolwa et l'absence de prise en charge alimentaire pour 40 patients à Lolwa (19), Mambasa (14) et Mandima (7) demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, l'absence d'échographe au CTE, l'insuffisance de lits au centre de traitement expérimental de Makiso-Kisangani et la démotivation de 12 ambulanciers sur 29 fragilisent la prise en charge.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie dans les ZS de Buta, Aketi et Viadana, avec le préenregistrement des leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs, portant le cumul provincial à 1 280 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (9,7 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %).
- **En Ituri**, la poursuite de l'étude sur l'immunité croisée Ervebo/Bundibugyo et de la vaccination des PPL reste suspendue à l'approvisionnement en vaccin Ervebo par le PEV national. **À la Tshopo**, 600 doses d'Ervebo et 600 seringues ont été réceptionnées et 9 400 doses supplémentaires sont annoncées dans la semaine.

2.6.2. Défis

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir, ce qui empêche le calcul d'un taux de couverture fiable.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC non effective, pas de disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, le suivi du CS Boyoma (ZS de Makiso-Kisangani) montre qu'au moins 14 malades tuberculeux y retirent chaque jour leurs médicaments et que l'incinérateur est fonctionnel, mais seuls 6 agents sur 38 (15,8 %) sont vaccinés, le laborantin n'est pas formé au diagnostic du paludisme et la zone de triage n'est pas effective ; le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis.
- **Au Bas-Uélé**, l'évaluation de la disponibilité des médicaments de la ZS de Ganga-Dingila (mai à août 2026) révèle une rupture persistante de Zinc + SRO, une remontée des stocks de RHZE (16 128 en août) et de nombreuses références d'ARV restées à zéro

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 23 782 visites à domicile ont touché 105 316 personnes ; 998 causeries éducatives ont réuni 20 218 personnes, 112 sensibilisations de masse ont touché 6 153 personnes et 5 plaidoyers 29 autorités et leaders. Au total, 389 alertes communautaires, dont 142 décès, ont été notifiées ; 308 feedbacks sur 319 (96,6 %) ont été recueillies et 5 incidents sur 6 (83,3 %) ont été résolus dans les 48 heures (complétude de 11 ZS sur 28, soit 39,3 %) ; la CREC a facilité le pré-listage de 311 contacts autour de 16 cas confirmés, la décontamination de 15 ménages sur 15 et de 4 structures sur 4, 21 EDS sur 21 et le transfert de 35 suspects sur 36 (97,2 %).
- **Au Nord-Kivu**, 10 654 visites à domicile ont touché 34 721 personnes, 230 causeries éducatives ont touché 7 449 personnes et 63 séances de communication de masse ont atteint 8 368 personnes ; 201 alertes communautaires sur 750 attendues (26,8 %) ont été notifiées, 13 feedbacks sur 17 (76,5 %) ont été résolus dans les 48 heures et 910 personnes sur 4 750 attendues (19,2 %) se sont engagées dans les actions communautaires. À Manguredjipa, une réflexion a réuni 22 membres de groupes de pression et résistants et un dialogue a été tenu avec 33 militaires des FARDC.

- **À la Tshopo**, 47 270 personnes (21 092 hommes et 26 178 femmes) ont été sensibilisées lors de 7 séances de masse à Bafwasende, Tshopo, Mangobo et Makiso-Kisangani, 3 causeries éducatives ont touché 187 personnes et un débat communautaire, avec le témoignage d'un guéri, a réuni 104 personnes à la paroisse Christ-Roi de Mangobo ; 4 émissions ont été animées, 258 affiches et 121 dépliants distribués, les 3 refus identifiés ont été levés et la CREC a appuyé l'investigation à Makiso-Kisangani et la désinfection des ménages à Makiso, Mangobo et Tshopo.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 39 confirmés en cours de suivi, 223 nouveaux suspects et 676 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les 10 ZS ayant notifié (100 %). Les équipes ont accompagné 31 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 31 (100 %), suivi 5 enfants en crèche sur 5 et 26 enfants sur 29 dans la communauté (89,7 %), réinséré 9 guéris, soutenu 87 PPL, réalisé la psychoéducation de 409 personnes (117 hommes, 146 femmes et 146 enfants) et annoncé 145 résultats, dont 39 positifs.
- **En Ituri**, 23 cas confirmés sur 57 (40,4 %) de la veille, 126 confirmés en cours de suivi sur 140 (90,0 %), 23 nouveaux suspects sur 73 (31,5 %) et 117 suspects en cours de suivi sur 128 (91,4 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 332 accompagnants et 73 PPL, suivi 13 guéris sur 17 (76,5 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 6 ménages d'enfants séparés sur 9, réinséré 2 guéris sur 4 et annoncé 41 résultats, dont 23 positifs.
- **À la Tshopo**, les 6 cas confirmés suivis au CTE Météo, dont 1 nouveau, ainsi que 7 nouveaux suspects sur 7 et 4 suspects en cours de suivi sur 4 ont été pris en charge (100 %) ; les équipes ont soutenu 21 PPL et 3 ménages, réinséré 2 déchargés dans la ZS de Kabondo, réalisé la psychoéducation de 46 personnes, levé 3 résistances sur 3 et annoncé 2 résultats, dont 1 positif ; 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (71,4 %).
- **Au Haut-Uélé**, seuls les CTE d'Isiro et de Wamba ont rapporté : 2 nouveaux confirmés, 8 confirmés en cours de suivi et 1 suspect en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; les équipes ont soutenu 13 accompagnants, 31 PPL et 13 enfants séparés en communauté, et annoncé 16 résultats, dont 3 positifs.
- **Au Bas-Uélé**, les activités SMSPS ont démarré avec l'arrivée d'un psychologue dans la ZS de Viadana (Limba) et 1 résultat a été annoncé (négatif).

2.9.2. Défis

- **En Ituriseules** 14 ZS affectées sur 28 sont couvertes (50,0 %) et la ZS de Mandima n'a aucune couverture SMSPS, ce qui impose de renforcer les capacités des psychologues et des APS/TPS pour assurer les interventions autour des cas.
- **Au Bas-Uélé**, la couverture SMSPS reste embryonnaire, les activités venant à peine de démarrer dans la ZS de Viadana.
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des unités de communication et des motos pour les déplacements du pilier.
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des moyens de communication et de déplacement du pilier.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, dotation de 6 lits et 6 matelas au CSR Limba pour le centre d'isolement et de matelas pour les guéris (OMS), déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active, et poursuite de la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS ainsi que de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta, dont les murs de pourtour sont achevés.
- **À la Tshopo**, suivi de la construction du CTE de Bafwasende, de l'isolement de Konga-Konga et de l'extension du CTE Météo, appui à la mobilité des piliers PCI, PEC, Communication et PoE/PoC et affectation d'un véhicule au CTE Météo.

- **Au Nord-Kivu**, 9 ambulances sur 11 (81,8 %) ont été mobilisées et les 16 courses demandées ont toutes été réussies (100 %), pour une capacité de réponse de 11 sur 28.

2.11. Sécurité

2.12. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, des hommes armés non identifiés ont tenté d'incendier les cabanes en construction du PoC Maboya, et la menace reste persistante contre les prestataires de tous les PoC de l'axe Butembo.
- **En Ituri**, le contrôle sanitaire des voyageurs au PoC de Zunguluka (ZS de Mambasa) est interrompu depuis le 03 octobre à 15 heures à la suite d'une attaque attribuée aux éléments ADF/NALU.

2.12.1. Principales actions

2.13. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.13.1. Principales actions

- **En Ituri**, 42 leaders communautaires, traditionnels et religieux (38 hommes et 4 femmes) ont été formés sur la PSEAH dans la ZS de Lita et ont signé le code de bonne conduite ; 487 personnes (343 hommes, 86 femmes, 31 garçons et 27 filles) ont été sensibilisées à Mahagi et l'affichage des messages s'est poursuivi à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki, mais seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.

2.13.2. Défis

Au niveau national, seule 1 DPS sur 7 (14,3 %) a rapporté ses activités PSEA ; en Ituri, les activités ne couvrent pas encore toutes les ZS touchées, les supports de sensibilisation de masse manquent et la cartographie des intervenants reste incomplète.

MESSAGES CLÉS

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé. Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures et une accalmie est observée dans la province de la Tshopo par rapport aux 72 dernières heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : Tous les cas suspects ont été investigués (100 %) dans les 24 heures suivant leur notification (100 %) des cas suspects ont également été investiguée à la même période suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est en légère hausse par rapport à la veille (79,7 vs 73,8%). Cependant, les efforts doivent être fournis afin que ce taux atteigne le seuil requis (95 %).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd